



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN II
TIM TB DOT'S
BULAN APRIL- MEI- JUNI 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA
PROGRAM TB-DOTS BULAN APRIL- MEI- JUNI 2026

I. SDM

1.1. Jumlah Kebutuhan SDM Tim TB-Dot

Tabel 1.1. Jumlah Kebutuhan SDM Tim TB-Dot

Jabatan	Jumlah SDM					Ket.
	Standar	APRIL	MEI	JUNI	Kebutuhan	
Ketua Tim TB DOTS	1	1	1	1	1	Sdm untuk tim tb-Dots cukup
Koordinator Program dan sekretaris TB DOTS	2	2	2	2	2	
Anggota Tim TB	10	10	10	10	10	
Kebutuhan	13	13	13	13	13	

1.2. Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 1.2. Pemenuhan Kualifikasi SDM

No	Jabatan	Pendidi-kan	Sertifikasi KEMENKES			
		Standar	ACLS (wajib)	PPI (wajib)	TB DOTS (wajib)	KE (wajib)
1.	Ketua Tim TB DOTS : dr. Andy, Sp.P(K)	Dokter Spesialis	V	V	V	V
2.	Ns.Tika Aryuni Damayanti , S.Kep	S1	V	V	V	V
3.	Oktavia Amelia Sari Amd.Kep	D3	V	V	V	V
4.	dr.Catur Elvi,Sp.P-Onk	Dokter Spesialis	V	V	V	V
5.	dr.Fiona Paramitha,Sp.A	Dokter Spesialis	V	V	V	V
6.	Apt. Dita Ariesa Putri Prajoko S.Farm	S1	-	V	V	V
7.	Elis Wahyuni,Amd.Ak	D3	-	V	V	V
8.	Tuti Dwi jayati, Amd.Keb,SE	D3	-	V	V	V
9	Ery Santoso, S. Kep. Ns.	S1	V	V	V	V
10	Ns. Isa Ariyanti,S.Kep	S1	V	V	V	V
11	Afni Nur Ainy, S.Kep,Ns	S1	V	V	V	V
12	Murwani Suryaning Sapartinah, S.Kep,Ns	S1	V	V	V	V
13	Isma Maulida Mufida, Amd.Rad	D3	-	V	V	V

Analisis

- 1) Kondisi SDM :
Jumlah Tim TB DOT'S secara keseluruhan adalah berjumlah 13 orang.
- 2) Program rotasi:
Program rotasi tim TB DOT'S berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim TB DOT'S dan bila ada anggota yang mutasi atau *resign*.
- 3) SIP, SIB DAN SIK, RKK-SPK
Tim TB DOT'S 100% sudah memiliki SIP, STR ,SIK dan masih berlaku.

Rencana tindak lanjut :
Koordinasi dengan SDM untuk segera membuat Diklat ACLS untuk memenuhi kualifikasi.

1.3. Kegiatan Diklat Bulan April- Mei- Juni Tahun 2026 di bidang TB DOTS
Tidak ada diklat TB-Dots pada bulan April- Mei- Juni Tahun 2026.

II. Pengembangan Pelayanan/Inovasi Baru

Berbagai inovasi dan pengembangan pelayanan baru untuk penanggulangan Tuberkulosis (TBC) berfokus pada peningkatan deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan yang lebih efektif.

III. Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan /MFK Tim TB DOT’S

Tabel 3.1. Alat Kedokteran Dan Alat Penunjang Yang Ada di Ruang TB Paru dan Non TB

No	Jenis	Kalibrasi	Jumlah	Kondisi Saat ini	Pemeliharaan	Ket
1	Mikroskop di Labolatorium TCM	-	-	-	-	Sampel dahak tcm di kirim ke pkm
2	Mikroskop di Labolatorium	-	1	Baik	Baik	
3	Lampu Baca radiologi	-	2	Baik	Baik	
4	Timbangan	-	1	Baik	Baik	
5	Stetoskop	-	2	Baik	Baik	
6	Exhause	-	2	Baik	Baik	
7	Spirometri	-	1	Baik	Baik	
8	Kipas Angin	-	3	Baik	Baik	

Evaluasi:
Secara umum kondisi fasilitas sarana dan prasarana TB DOT’S dalam kondisi baik, peletakan sudah sesuai dengan standart PPI.

Rencana Tindak Lanjut:
a. Koordinasi dengan bagian IPSRS untuk kalibrasi dan servise alat penunjang medis non elektrik maupun yang elektrik sesuai jadwal yang sudah diberikan keperawatan.
b. Koordinasi dg PPI untuk penataan di dalam Poli TBC.

IV. Pelayanan TB DOTS

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya melalui kegiatan : 1. Promosi kesehatan a. surveilans tuberculosi b. pengendalian factor risiko c. penemuan dan penanganan kasus	a. Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien tentang tuberculosi melalui webinar, poster, leaflet, penyuluhan. b. Melakukan pencatatan harian pasien TB baru, TB lama, rujukan masuk dan rujukan keluar

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
	d. pemberian kekebalan e. pemberian obat pencegahan.	c. Pencatatan pasien, HIV, pasien DM, screening pasien paru dg DM, Riwayat kontak dengan keluarga d. Melakukan Observasi kegiatan e. Pemberian vaksin BCG kolaborasi dengan PPK 1 dan poli anak f. Pemberian obat inh dan rimfampentil pada pasien dengan Riwayat kontak erat.
2	Melakukan pelatihan pelayanan dan upaya penanggulangan tuberculosis	• Menyusun jadwal • Membuat proposal kegiatan • Membuat undangan kegiatan • Membuat daftar hadir • Membuat materi pelatihan • Membuat soal Pre dan Post test • Membuat Notulen pelatihan • Membuat sertifikat pelatihan • Melakukan evaluasi • Membuat lapporan
3	Tersedia ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis	• Koordinasi degan tim PPI untuk tersedianya rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis
4	Tersedia ruang pelayanan rawat inap dewasa bagi pasien tuberculosis paru yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis	• Koordinasi dg kbid pelayanan • Koordinasi dg kbid keperawatan • Koordinasi degan tim PPI untuk tersedianya rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis
5	Tersedia ruang pengambilan specimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis	• Tersedianya pojok dahak pengambilan sputum sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis
6	Tersedia ruang laboratorium tuberculosis yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis	• Tersedianya ruang pemeriksaan dahak sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis
7	Kepatuhan staf medis terhadap Panduan praktik klinis tuberculosis	• Ketersediaan PPK Tuberculosis
8	Terlaksana proses skrining pasien tuberculosis saat di pendaftaran	• Screening pasien Tuberculosis di pendaftaran
9	Kepatuhan staf dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien atau specimen	• Koordinasi dengan PPI
10	Kepatuhan pengunjung terhadap penggunaan alat pelindungdiri (APD) saatkontak dengan pasien.	• Koordinasi dengan PPI
11	Rapatkoordinasi dengan manajemen rumahsakit	Melaporkan hasil kegiatan pelayanan Tuberkulosis

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
12	Rapat koordinasi dengan IGD, Poli Penyakit Paru, Polipenyakitdalam, Instalasi Rawat Inap, ICU, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium	Membahas hasil mutu pelayanan Tuberkulosis dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kasus.
13	Rapatkordinasi Tim PelayananTuberkulosisRumahSakit	Membahas kegiatan pelayanan Tuberkulosis. ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi

Analisis

- 1) Melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis baik Promosi kesehatan, surveilans tuberkulosis, pengendalian factor risiko, penemuan dan penanganan kasus, pemberian kekebalan serta pemberian obat pencegahan.
- 2) Adanya ruang pengambilan specimen sputum
- 3) Kepatuhan staf medis harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) tuberkulosis
- 4) Dilakukanya rapat koordinasi Tim Pelayanan Tuberkulosis Rumah Sakit

3.1. Skrining Pasien

Tabel 3.1.1 Pasien Dan Keluarga Serta Pengunjung Yang Menerima Masker di RSPHM Pada Bulan April s/d Juni tahun 2026

No	Jenis Skrining	Jumlah Pasien			Ket
		April	Mei	Juni	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0	0	0	
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0	0	1	
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	0	0	0	

Evaluasi :

- 1) Pada bulan April 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 2) Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3) Pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1) Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

Tabel 3.1.2. Kinerja skrining Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Pada Bulan April Tahun 2026 di RSPHM

No	Pelaksanaan	usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	01/04/2026	36 th	-	Positif	Positif	-
2	07/04/2026	24 th	-	Positif	Positif	-
3	08/04/2026	49th	-	Negatif	Positif	-
4	10/04/2026	71th	-	Positif	Positif	-
5	13/04/2026	76th	-	Negatif	Positif	-
6	14/04/2026	74th	-	Positif	Positif	-
7	25/04/2026	2th	Negatif	-	Negatif	Positif
8	29/04/2026	61th	-	Negatif	Positif	-
9						
10						
11						
12						
13						
	Total		1	4	7	1

Tabel 3.1.3. Kinerja skrining Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Pada Bulan Mei Tahun 2026 di RSPHM

No	Pelaksanaan	usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	04/05/2026	28th	-	Negatif	Negatif	Positif
2	06/05/2026	42th	-	Negatif	Positif	-
3	07/05/2026	74th	-	Positif	Positif	-
4	14/05/2026	1th	Negatif	-	Negatif	Positif
5	28/05/2026	20th	-	Positif	Negatif	-
6						
7						
8						
9						
10						
	Total			2	2	2

Tabel 3.1.4. Kinerja skrining Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Pada Bulan Juni Tahun 2026 di RSPHM

No	Pelaksanaan	usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	02-06-2026	3th	Positif	-	Negatif	-
2	08-06-2026	50th	-	Positif	Negatif	-
3	09-06-2026	43th	-	Positif	Positif	-
4	16-06-2026	55th	-	Negatif	Positif	-
5	18-06-2026	58th	-	Positif	Positif	-
6	22-06-2026	28th	-	Positif	Positif	-

7	22-06-2026	25th	-	Negati	Negati	Positif
8	26-06-2026	20th	-	Positif	Positif	-
9						
10						
	Total	8	1	5	5	1

- Evaluasi :**
- 1) Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
 - 2) Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
 - 3) Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1) Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB.

3.2. Penemuan Kasus TB

3.2.1. Tabel Kinerja Penemuan suspek TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Poli Paru	5	2	4
2	Poli Bedah			
3	Poli Saraf			1
4	Poli Anak	1	1	1
5	Irna 2C			
6	ICU		1	
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	2	1	2
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total	8	5	

- Evaluasi:**
- 1) Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
 - 2) Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien

- 3) Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien

Rencana Dan Tindak Lanjut:

- 1) Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.3. Kunjungan pasien TB

Tabel 3.3.1. Kunjungan Pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		April	Mei	Juni	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	63	49	47	
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	0	4	3	
3	Pasien RFT	8	5	8	

Evaluasi :

- 1) Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan April mencapai 63 pasien, di bulan Mei 49 pasien, dan di bulan Juni 47 pasien.
- 2) Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan April 0 pasien, di bulan Mei 4 pasien dan di bulan Juni 3 pasien.
- 3) Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFT di bulan April 8 pasien, di bulan Mei 5 pasien dan di bulan Juni 8 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Meningkatkan kunjungan pasien

3.4. Pemberian Obat Pencegahan

Tabel 3.4.1. Jumlah Keluarga Pasien Kontak Yang Dirujuk ke PKM Untuk Pemberian Obat Preventif INH di RSPHM Pada Bulan April s/d Juni Tahun 2026

No	Pemberian Obat Pencegahan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Sasaran keluarga pasien yang kontak dengan pasien TB	8	5	8

Evaluasi :

- 1) Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH) di Rumah Sakit Prima Husada dikarenakan ketidak tersedianya obat pencegahan /TPT di Rumah Sakit Prima Husada.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).

- 2) Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.5 Pemberia Imunisasi BCG

3.5.1 Tabel Pemberian Imunisasi BCG

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1	Pemberian imunisasi BCG	4	2	2

Evaluasi :

- 1) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan April
- 2) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
- 3) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG.
- 2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulan nya.

3.6 Kinerja MUTU

3.6.1 Tabel Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan April 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.I	V		
		Ny.H	V		
		Tn. R	V		
		Tn. I	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S	V		
		Ny.K	V		
		Tn.D	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A				
4.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

3.6.2 Tabel Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Mei 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.D	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. NP	V		
		Tn. B	V		MENINGGAL SEBELUM PENGOBATAN
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				
4.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A	An. A	V		

3.6.2 Tabel Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juni 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. S	V		
		Ny. R	V		
		Ny. ET	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. T	V		
		Ny. N	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. B	V		
4.	Dr. Farid, Sp.N	Ny. N	V		

Analisis

1. Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang.

3.7 INDIKATOR MUTU Program TB DOTS

3.7.1 Indikator Mutu Angka Keberhasilan Pengobatan Program TB DOTS

No	Pengukuran Mutu Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Standar	Hasil
1	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis Bulan April 2026	100%	100%
2	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis Bulan Mei 2026	100%	100%
3	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis Bulan Juni 2026	100%	100%

Analisis

- 1) Terjadi penurunan angka pasien tenkonfirmasi bakteriologis yang diiringi dengan peningkatan jumlah tes TB, hal ini berdampak positif karena banyaknya pasien yang sadar akan pentingnya skrinning TB ketika pasien memiliki gejala batuk dan sesak nafas

Rencana tindak Lanjut

- 1) Tetap mempertahankan angka penurunan pasien tenkonfirmasi bakteriologis yang diiringi dengan peningkatan jumlah tes TB

3.8 Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring

Pemantauan atau Monitoring dilakukan dalam bentuk

- a. Observasi setiap kunjungan pasien.
- b. Supervisi di lakukan oleh kader team Yabisa.

3.8.1 Tabel Jadwal kegiatan Instalasi bulan ini adalah:

No	Kegiatan	Pemenuhan*
1	Validasi Laporan TB DOTS	1 Bulan
2	Order OAT	1-2 Bulan
3	Order BHP TB DOTS	2 Minggu

*Pemenuhan diisi dengan: sesuai jadwal/ditiadakan/direncanakan mundur/dijadwal ulang/dst.

Analisis

- 1) Validasi laporan dan pengorderan OAT dan BHP TB DOTS dilakukan sesuai dengan jadwal dan keperluan

Rencana Tindak Lanjut

- 1) Pengorderan obat TB dilakukan oleh Tim Penanggung Jawab Tb dan IFRS, sehingga harus selalu difasilitasi oleh ambulance saat melakukan permintaan OAT dan BHP TB DOTS

3.9 Evaluasi Proker TB-DOTS

Evaluasi dilakukan dengan pengumpulan Data dan kegiatan untuk dibuat laporan Jenis Laporan : Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.

3.9.1. Rapat Koordinasi dilaksanakan di TW II (April s/d Juni)

Tampilkan Notulen

No	Masalah yang ditemukan dan dibahas	RTL	PIC	Waktu penyelesaian
1.	Angka Keberhasilan Pengobatan	Dengan cara minum obat Oat secara rutin dilihat dari hasil dahak evaluasi dan ceklis pengobatan	Dr. Andy.Sp.P	6-9 bulan
2.	Angka Kepatuhan Minum Obat	Dengan cara pengawasan melalui orang terdekat atau keluarga yang satu rumah dan bersedia	Dr. Andy.Sp.P	6-9 bulan

		mendapat penyuluhan bersam-sama dengamn pasien		
--	--	--	--	--

4.0 Kinerja PPI Tim TB-DOTS

Tabel 4.0.1 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	100%
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	100%

Evaluasi :

- 1) Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

Tabel 4.0.2 Kepatuhan Pengunjung Pasien Diruang tunggu Terhadap APD Menggunakan masker sesuai standart

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Evaluasi :

- 1) Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penularan karena disebabkan meningkat nya pasien tbc tiap tahunnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung dan menanyakan keluarga dari pasien IGD, Irna, Irja, ICU, HCU dan Ruang isolasi wajib menggunakan masker, dan anak usia di bawah 12th dilarang berkunjung, agar mengurangi resiko penularan virus.

4.1 Penempatan Pasien TB

Tabel 4.1.1 Penempatan Paien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%	100%	100%
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%	100%	100%
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%	100%	100%

Evaluasi :

- 1) Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

4.2 Pasien TB Yang Dirujuk Di Fasyankes / Rs Lebih Tinggi

4.2.1 Tabel Pasien TB Yang Dirujuk Di Fasyankes / Rs Lebih Tinggi Di Bulan April 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Januari	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny.S	V	-	1	PKM Karangploso	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Tn.D	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

4.2.2 Tabel Pasien TB Yang Dirujuk Di Fasyankes / Rs Lebih Tinggi Di Bulan Mei 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Februari	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru						
	Poli Paru						
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						

4	Poli Anak	An. A	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

4.2.2 Tabel Pasien TB Yang Dirujuk Di Fasyankes / Rs Lebih Tinggi Di Bulan Juni 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Maret	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny. T	V	-	1	PKM Lawang	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Ny. N	V	-	1	PKM Kendal Kerep	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli Saraf	Ny. N	V	-	1	PKM Polowijen	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						

	Total						
--	-------	--	--	--	--	--	--

- Evaluasi :**
- 1) Pada bulan April 2026 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2) Pada bulan Mei 2026 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 3) Pada bulan Juni 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena memilih lebih dekat dengan rumahnya.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1) Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

4.3 Distribusi Pasien TB Paru dan Ekstra Paru

4.3.1 Tabel Distribusi Pasien Tb Paru Dan Ekstra Paru

No	Jenis TB	Jumlah Pasien					
		APRIL		MEI		JUNI	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1.	Pasien paru	0	7	0	3	1	6
2.	Pasien Ekstra paru	1	0	1	1	0	1

- Evaluasi :**
- 1) Pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru
 - 2) Pada bulan Mei 2026 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 3 pasien paru
 - 3) Pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1) Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru.

4.4 Kinerja Produktivitas

4.4.1.Table Kinerja Produktifitas Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		APRIL	MEI	JUNI	
1.	OAT Anak	3	2	5	01/27
2.	OAT Harian Dewasa	10	4	7	11/26
3.	Ethambutol 250 mg	0	0	300	0
4.	Ethambutol 400 mg	0	0	0	0
5.	Pirazinamid 500 mg	632	632	632	05/27
6.	Isoniazid 300 mg	404	304	204	08/26
7.	Rimfapicin 450 mg	1082	1082	620	03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0	0	0	0

- Evaluasi :**
- 1) Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

4.5 Kinerja PKRS Tim TB-DOTS

4.5.1. Tabel Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis Tim TB-DOTS RSPHM Bulan April s/d Juni Tahun 2026

No	Judul KIE kelompok	Pelaksana	Bulan			Media	Metode
			April	Mei	Juni		
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	Poli TB dan Non Tb	17-04-2026	02-05-2026	02-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
2	Peran Pengawas Menelan Obat	Poli TB dan Non Tb	01-04-2026	02-05-2026	02-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
3	Penggunaan APD Dan Etika Batuk	Poli TB dan Non Tb	17-04-2026	06-05-2026	06-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
4	Hand Hygiene	Poli TB dan Non Tb	01-04-2026	06-05-2026	06-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
5	PPOK	Poli TB dan Non Tb	09-04-2026	11-05-2026	11-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
6	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Poli TB dan Non Tb	16-04-2026	16-05-2026	16-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
7	Pneumonia	Poli TB dan Non Tb	09-04-2026	11-05-2026	11-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
8	Teknik Batuk Efektif	Poli TB dan Non Tb	16-04-2026	16-05-2026	16-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
9	Tuberculosis	Poli TB dan Non Tb	24-04-2026	26-05-2026	26-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
10	TBC Anak	Poli TB dan Non Tb dan Poli Anak	29-04-2026	26-05-2026	26-06-2026	Leaflet	Penyuluhan
	Total Jumlah Peserta	15	15	15	15		

Evaluasi:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti : pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

4.6 PENUTUP

Demikian laporan triwulan TBC-DOTS pada bulan April-Mei-Juni tahun 2026 kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta pencapaian indicator program TBC di bulan berikutnya.

kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu kelancaran untuk laporan triwulan.

Malang, 30 Juni 2026
Direktur Prima Husada



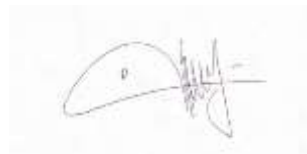
dr. Resti Lestantini, M.Kes

Ketua Tim TB DOTS
Prima Husada



dr. Andy, Sp.P

Sekretaris Tim TB



Tika Aryuni Damayanti, S.Kep,Ns